

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: ENFERMEDAD DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA.

Miguel Pérez Ferrer, Giancarlo Ernesto Candela Ganoza, Isabel Maestro Prada, Eva Marina Fernández-Marcote Menor.

INTRODUCCIÓN

Enfermedad inflamatoria crónica sistémica mediada por mecanismos autoinmunes que típicamente cursa en brotes. Se subdivide en tres entidades según su comportamiento, localización e histología:

- **Colitis Ulcerosa:** Afectación limitada a la mucosa colónica (intestino grueso o colon) cuya distribución es difusa y continua. Presentación típica con diarrea, rectorragia y dolor abdominal tipo retorcijón y/o síndrome rectal (tenesmo, urgencia defecatoria y pujos).
- **Enfermedad de Crohn:** Se caracteriza por afectación transmural de cualquier punto del tracto GI, cuya distribución es parcheada, más frecuente en íleon y colon. Cursa con fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso y diarrea con o sin productos patológicos (en patrón estenosante puede cursar con episodios suboclusivos). Prevalencia en aumento, recientemente igualando a la colitis ulcerosa.
- **Colitis Indeterminada (10%):** Cuando no se consigue establecer diferencia entre las anteriores (a efectos de manejo práctico se trata como colitis ulcerosa).

DIAGNÓSTICO

Los motivos por los que un paciente con EII acude a urgencias son: La presencia de un brote, enfermedad perianal, una complicación (obstrucción intestinal, perforación-absceso, hemorragia digestiva...), efectos adversos del tratamiento o manifestaciones extraintestinales (oculares como la uveítis anterior, articulares o cutáneas como el eritema nodoso y pioderma gangrenoso principalmente).

Anamnesis

Dolor abdominal, el número de deposiciones, presencia o ausencia de productos patológicos, tenesmo rectal, rectorragia. Pérdida de peso, fiebre o febrícula. Clínica extraintestinal o perianal.

Fármacos: Cumplimiento terapéutico. Uso de AINES o antibióticos. Relación temporal fármaco-clínica.

Estratificación de la actividad en brote:

Índice Actividad Enfermedad de Crohn: Harvey Bradshaw	
1.- Estado General	• 0: Muy bueno • 1: Regular • 2: Malo • 3: Muy malo • 4: "Terrible"
2.-Dolor abdominal	• 0: No • 1: Leve • 2: Moderado • 3: Intenso
3.- Numero deposiciones líquidas diaria (n)	• N

Índice Actividad Enfermedad de Crohn: Harvey Bradshaw	
4.- Masa abdominal	• 0: No • 1: Dudosa • 2: Definida • 3: Definida y dolorosa
5.- Complicaciones:	• 1 punto por cada una de las siguientes: • Artralgia, uveítis, aftas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, fístula anal activa, otras fistulas activas, absceso.
Puntuación: <6: Brote Leve; 6-12 Brote Moderado; >12 Brote grave.	

Índice Actividad Colitis Ulcerosa: Truelove Witts

	1 punto	2 puntos	3 puntos
• Número deposiciones	• <4	• 4-5	• >5
• Sangre heces	• +-	• ++	• +++
• Tª axilar (°C)	• <37	• 37-37.5	• >37.5
• FC (lpm)	• <80	• 80-90	• >90
• Hb (g/L) Hombres.	• >14	• 10-14	• <10
• Mujeres	• >12	• 9-12	• <9
• VSG (mm/h)	• <15	• 15-30	• >30

Puntuación: 6 puntos: inactivo; 7-10 puntos: leve; 11-14 puntos: moderado; 15-18 puntos: grave.

Pruebas complementarias:

- Hemograma.
- Coagulación.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, PCR / VSG. Procalcitonina.
- Coprocultivo, toxina de Clostridium difficile (incluir parásitos al diagnóstico).
- Rx abdomen: Si dolor abdominal, para descartar complicación como oclusión, perforación o megacolon tóxico (colon transversal > 6cm con signos de toxicidad sistémica).
- Rx Tórax: Ante cualquier brote que requiera ingreso. Estudio Síndrome febril (especialmente si clínica respiratoria o tratamiento inmunosupresor).
- TAC / RMN / Eco intestinal: En caso de sospecha de complicación local/abdomen agudo: absceso, fístula, colitis grave y perforación. Su indicación no es urgente. Contraindicación si megacolon.
- Rectoscopia: si brote grave de Colitis ulcerosa, rectoscopia para biopsias para descartar CMV.

TRATAMIENTOIndicaciones de ingreso

Todo brote grave de acuerdo con los índices de estratificación.

- Brote moderado que no ha respondido al tratamiento o con intolerancia oral.
- Sospecha de complicaciones: Abdomen agudo, hemorragia digestiva grave, síndrome febril sin foco y/o en paciente bajo tratamiento inmunosupresor.

ENFERMEDAD DE CROHN

La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, la clínica de la enfermedad de Crohn es diversa, abigarrada y depende de su localización. En general pueden presentar desde diarrea a veces con sangre, moco o pus, dolor abdominal con fiebre y en algunas ocasiones, llegando a veces a presentar cuadros obstructivos y fistulas de origen variado.

Brote leve-moderado

- Ileocecal: Budesonida 9mg/24h oral 4 semanas (Intestifalk® o Entocord®). Pauta descendente: 6mg/24h 2 semanas, 3mg/24h 2 semanas y luego suspender.
- No ileocecal (Colon, Intestino delgado o tracto digestivo superior):
 - Prednisona 60mg/24h oral 2 semanas con descenso gradual de 10mg a la semana hasta 20 mg y posteriormente de 5 en 5 mg hasta suspender.
 - Si corticodependencia descenso a partir de las 2 semanas, más lento.

Brote grave

- Ingreso + Metilprednisolona 60mg/24h iv + Profilaxis de Enf. Tromboembólica + soporte nutricional
- En caso de no respuesta a corticoides IV en el brote grave (Corticorefractariedad) valorar iniciar AntiTNF como Infliximab 5mg/kg iv (semanas 0-2-6). Previo al inicio de terapia biológica con AntiTNF consultar con digestivo y verificar ausencia de contraindicación e infección latente: Pedir serologías (VIH, virus hepatotropos), IGRA/ Mantoux (con Booster si inmunosupresión), Radiografía de tórax, ANA, y descartar CMV).

Absceso abdominal

- Ingreso + Prednisona 60mg/24h oral + Antibioterapia de amplio espectro (Ciprofloxacino 500mg/12h + Metronidazol 500mg/12h, Tazocel 4g/8h o Meropenem 1g/8h) + Drenaje percutáneo siempre que se pueda, sobre todo si > 3cm. Si no abordable o no respuesta al antibiótico, drenaje quirúrgico si >3 cm.
- Si absceso perianal: Añadir además del drenaje quirúrgico, colocación de setón si se puede.

Estenosis sintomática

- Observación al menos 24-48 horas para valoración clínica y evolutiva.
- Radiografía de abdomen y/o TAC abdomino-pélvico.
- Metilprednisolona 60mg/24h iv + Ayuno y sueroterapia inicial con corrección hidroelectrolítica.
- Si niveles hidroaéreos, colocar SNG. Si no repuesta clínica nutrición parenteral y valoración quirúrgica.
- Si buena evolución, sin niveles y con presencia normal de ruidos hidroaéreos, dieta oral líquida, batidos nutricionales si los necesita y se pasan los CE a orales con el resto de la medicación.

COLITIS ULCEROSA

El tratamiento dependerá de la gravedad y de la extensión de la afectación mucosa (para esto es

fundamental revisar colonoscopias previas). El tratamiento se basa en dos pilares: Tópico, que debe iniciarse en todos los casos y sistémico.

Brote leve-moderado

Tratamiento tópico con 5-ASA (1-4g/24h). Claversal, Pentasa, Salofalk.

Presentación elegida según afectación mucosa, aunque también teniendo en cuenta la tolerancia del paciente a cada una de las formas de administración.

- Proctitis: Supositorio. Alta tolerabilidad y retención.
- Colitis izquierda: Enemas o espuma rectal: Alcance hasta ángulo esplénico, peor tolerancia.
- Alternativa a Mesalazina tópica: Enemas de Budesonida (2 mg/ 12 horas). Peor respuesta.
- Si pancolitis con sintomatología proctológica.

Tratamiento oral

- 5-ASA oral Mesalazina 4-4.8 g/día: Claversal, Pentasa, Salofalk, Asacol, Mezavant. Si colitis izquierda y pancolitis, se debe asociar al tratamiento tópico previamente mencionado
- Corticoides orales de baja biodisponibilidad Dipropionato de beclometasona: Clipper: 5 mg/24h vía oral durante 4 semanas y después a días alternos otras 4 semanas. Deben añadirse si no hay buena respuesta a la Mesalazina tras 1-4 semanas de tratamiento. Considerar especialmente en pacientes que llevaban terapia de mantenimiento con 5-ASA a dosis > 2 g/día.
- Si no respuesta al CE de baja biodisponibilidad, empezar con Prednisona oral 60mg/día.

Brote grave

Ingreso + Metilprednisolona 60mg/24h iv + Tratamiento tópico con 5-ASA (según la pauta indicada previamente). Añadir profilaxis de enfermedad tromboembólica + soporte nutricional (oral o parenteral).

Si no hay respuesta al tratamiento con corticoides iv tras 3 días, deberá valorarse iniciar terapia de rescate (ciclosporina, Infliximab o cirugía si no hay respuesta).

Si se sospecha complicación séptica (fiebre alta, peritonismo, sospecha colitis infecciosa) iniciar:

- **Antibioterapia:** ceftriaxona 2 g/24 horas o ciprofloxacino 400 mg/12 horas + metronidazol 500 mg/8 h, si grave o sospecha de germen nosocomial: tazocel 4g/8h o meropenem 1g/8h.

Previo al inicio de terapia biológica con AntiTNF consultar con digestivo y verificar ausencia de contraindicación e infección latente: pedir serologías (VIH, virus hepatotropos), IGRA/ Mantoux (con Booster si inmunosupresión), Radiografía de tórax, ANA, y descartar CMV.

Megacolon tóxico

Complicación poco frecuente pero grave de una colitis fulminante.

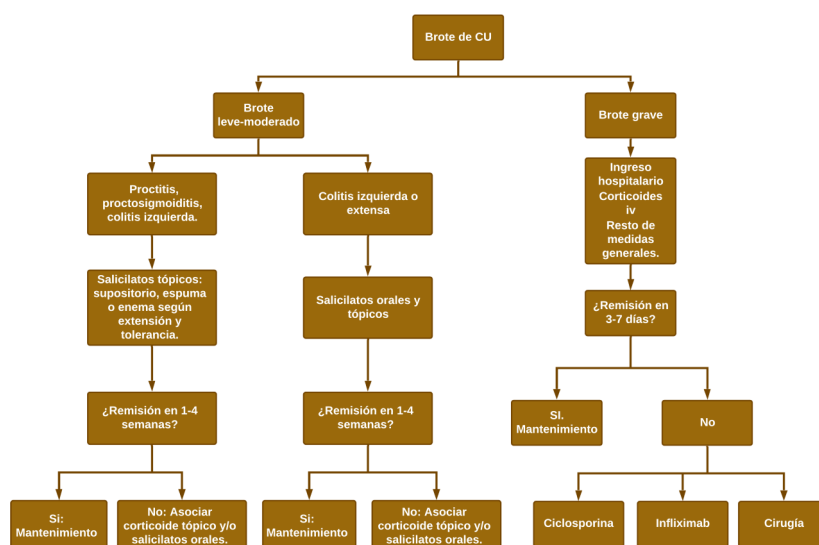
DIAGNÓSTICO

Dilatación colónica (>6 cm) asociado a datos de toxicidad sistémica definidos por los **criterios de Jalan** como la presencia de tres de los siguientes: fiebre de más de 38-5°C, FC > 120 lpm, leucocitosis mayor de o anemia, y además, como mínimo uno de los síntomas: deshidratación, alteración conciencia, alteraciones electrolíticas, hipotensión.

Es conveniente realizar en los brotes graves radiografías de abdomen seriadas (24-48 horas).

TRATAMIENTO.

- Ingreso en UCI / cuidados intermedios. Valoración conjunta médico-quirúrgica.
- Tratamiento del brote de Colitis (Ver brote grave)
- Dieta absoluta + Sonda nasogástrica + Corrección alteraciones hidroelectrolíticas
- Antibioterapia iv de amplio espectro como (Tazocel 4gr/8h)
- Cirugía: El tratamiento quirúrgico precoz mejora el pronóstico en estos pacientes y está indicado en las siguientes situaciones:
- Mala respuesta a tratamiento a las 48-72 horas: empeoramiento estado tóxico, dilatación progresiva del colon.
- Hemorragia incoercible.
- Perforación.



Manejo brote de CU. Modificado de: Conductas de actuación en Enfermedad Inflamatoria Crónica Intestinal. 6ª Edición. GETECCU.

No olvidar

- Todo brote moderado-grave requiere profilaxis tromboembólica (Hibor 3500UI cada 24h subcutáneo o Clexane 40mg/24h subcutáneo).
- Siempre suplementar calcio (1-1.5 gramos / día) y vitamina D (800 UI / día) e IBP (Omeprazol 20mg/24h) al iniciar tratamiento con corticoides (sistémicos y de baja biodisponibilidad)
- No suspender tratamiento de base salvo toxicidad farmacológica o sospecha de infección activa grave.
- Evitar uso de AINES, espasmolíticos, antidiarreicos y opioides.
- Nutrición oral precoz salvo intolerancia alimentaria por vómitos, abdomen agudo o clínica obstructiva. En los brotes graves debe iniciarse desde el principio Nutrición enteral suplementaria si la vía oral es tolerada. Aunque el paciente tenga un buen estado nutricional al inicio del proceso, el estado inflamatorio provoca un consumo extremo de proteínas.
- Ferroterapia iv precoz en caso de anemia/ferropenia.
- Uveítis: Disminución de la agudeza visual, dolor ocular, cefalea y ojo rojo. Iniciar tratamiento corticoideo (Metilprednisolona 60mg/24h) y valoración por oftalmólogo urgente.

BIBLIOGRAFÍA.

- Hinojosa del Val J, Nos Mateu P, Alós Company R. Conductas de actuación en la Enfermedad

Inflamatoria Crónica Intestinal. Manual Práctico. 6ª Ed. Madrid: Ergon; 2014.

- Gomollón F, Dignass A, Annese V, Tilg H, Van Assche G, Lindsay JO et al. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn's Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management. J Crohns Colitis. 2017;11(1):3-25.
- Harbord M, Eliakim R, Bettenworth D, Karmiris K, Katsanos K, Kopylov U et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. J Crohns Colitis. 2017;11(7):769-84.